

가상 건강검진 결과지

Virtual Health Check Report - Sample

중요 안내: 본 문서는 앱 화면에 표시된 제한된 생체·체성분 데이터를 기반으로 생성한 가상 샘플입니다. 실제 의료기관의 검진이나 의사의 대면 진료를 대체하지 않습니다.

문서번호	HU-VHC-20260709-0003	작성일	2026.07.09
성명	박지훈	성별/생년월일	남 / 1981.02.17
추정 연령	45세	작성기관	헬스업 가상 건강관리센터

1. 검사 결과 요약

검사항목	측정값	단위	가상 판정	해석 메모
심박	75	bpm	정상	안정시 일반 참고범위 60-100 bpm 기준
혈당	131	mg/dL	높음/당뇨 관리 필요	공복혈당으로 가정 시 126 mg/dL 이상은 당뇨병 범위로 평가 가능
혈압	139/87	mmHg	높은 정상/고혈압 관리 필요	고혈압 병력이 있는 경우 목표혈압 달성 여부 확인 필요
몸무게	88	kg	기록	단독 수치로 질환 판단 불가
BMI	29.8		비만	아시아 성인 기준 BMI 25 이상은 비만 범위, 30에 근접
골격근량	27.3	kg	근육량 관리 필요	체중 대비 근육량 유지와 체지방 감량을 함께 관리 권장
체지방률	30	%	높음	남성 기준 체지방률이 높은 편으로 복부비만 및 대사위험 확인 권장

※ 신장 정보가 화면에 표시되지 않아, 체중 88 kg과 BMI 29.8을 이용하면 추정 신장은 약 171.8 cm입니다. 실제 입력 신장과 다를 수 있습니다.

2. 종합 판정

제공된 수치만 기준으로 심박은 정상 범위이나, 혈당 131 mg/dL은 공복 상태 측정값이라면 당뇨병 범위에 해당할 수 있습니다. 혈압 139/87 mmHg는 고혈압 병력이 있는 사용자에게는 조절 상태 확인이 필요한 수치이며, BMI 29.8과 체지방률 30%는 비만 및 대사위험 관리가 필요한 상태로 해석할 수 있습니다. 단일 시점의 앱 데이터이므로 확정 진단은 불가하며, 반복 측정과 의료기관 상담이 권장됩니다.

3. 추가 확인 권장 항목

항목	권장 내용
혈압 재측정	가정혈압을 1-2주간 아침/저녁으로 안정 후 2회 측정하여 평균 확인
혈액검사	공복혈당, HbA1c, 지질검사, 간기능, 신장기능, 전해질 검사
체성분/복부비만	허리둘레, 체지방률, 골격근량을 동일 기기·동일 조건으로 추적
생활기록	수면, 운동량, 식사, 나트륨 섭취, 음주·흡연 여부, 가족력 확인

가상 의사진단 및 소견서

Doctor Opinion Sample - Not for clinical use

문서번호	HU-VHC-20260709-0003	작성일	2026.07.09
성명	박지훈	성별/생년월일	남 / 1981.02.17
추정 연령	45세	작성기관	헬스업 가상 건강관리센터

1. 가상 진단/판정

구분	가상 진단/판정	근거
혈압	고혈압 병력 기반 조절상태 재평가	139/87 mmHg, 병력 태그 고혈압 확인
혈당	당뇨병 관리 필요	131 mg/dL - 공복 여부 및 HbA1c 확인 필요
체중/BMI	비만 관리 권장	BMI 29.8, 추정 신장 약 171.9 cm
체성분	체지방률 높음, 근육량 유지 필요	체지방률 30%, 골격근량 27.3 kg
종합	심혈관·대사 위험요인 관리 필요	고혈압/당뇨병 병력 + 비만 + 체지방률 상승

2. 의사 소견

- 혈압 139/87 mmHg는 단일 측정값만으로 조절 상태를 확정할 수는 없지만, 고혈압 병력이 있는 경우 목표혈압 도달 여부와 약물/생활요법 조정 필요성을 확인해야 합니다.
- 혈당 131 mg/dL은 공복 상태로 측정한 값이라면 당뇨병 범위에 해당할 수 있으므로 HbA1c와 식후혈당 확인이 권장됩니다.
- BMI 29.8, 체지방률 30%, 골격근량 27.3 kg 조합은 체중 감량과 체지방 감소가 필요한 패턴입니다. 단, 근육량 손실을 막기 위해 무리한 절식보다 근력운동과 단백질 섭취, 나트륨 및 당류 조절을 병행하는 것이 좋습니다.
- 두통, 흉통, 호흡곤란, 시야 흐림, 마비감, 심한 어지러움이 동반되거나 혈압이 180/120 mmHg 이상이면 즉시 진료가 필요합니다.

3. 권고사항

영역	권고 내용	추적 기준
혈압	가정혈압계를 이용해 아침 기상 후와 저녁 안정 시 각각 2회 측정, 평균값 기록	1-2주
혈당	공복/식후 혈당을 구분해 기록하고 HbA1c 검사로 당뇨 조절 상태 확인	3개월
운동	중등도 유산소 150분/주 + 전신 근력운동 2-3회/주, 갑작스러운 고강도 운동은 피함	4주 단위
영양	나트륨·당류·야식 줄이기, 단백질은 매 끼니 분산 섭취, 채소·통곡류 비중 확대	상시
진료	반복 혈압·혈당이 높거나 기존 처방약 조정이 필요하면 내과 또는 가정의학과 상담	가급적 1개월 내

가상 담당의: 홍길동 / 가정의학과 전문의(가상) 면허번호: SAMPLE-00000

소견서 발행기관: 헬스업 가상 건강관리센터 서명: 전자서명(샘플)

가상 처방전

Prescription Sample - Medication not prescribed

본 처방전은 실제 약제 처방전이 아니며, 건강관리 앱/서비스 시연을 위한 문서입니다. 약물 복용은 반드시 실제 의사 또는 약사의 지시에 따라야 합니다.

문서번호	HU-VHC-20260709-0003	작성일	2026.07.09
성명	박지훈	성별/생년월일	남 / 1981.02.17
추정 연령	45세	작성기관	헬스업 가상 건강관리센터

1. 약제 처방

약품명	용량/용법	일수	비고
해당 없음	현재 문서는 가상 문서이므로 실제 약물 처방 없음	-	고혈압/당뇨병 병력 확인 후 실제 진료에서 약물 조정 여부 결정
고혈압·당뇨병 약제 검토	실제 진료 후 적응증 해당 시 결정	-	임의 복용 금지. 신장기능, 간기능, 전해질, 병용약, 저혈당 위험 확인 필요

2. 생활습관 처방

처방 영역	세부 처방	빈도/기간
혈압 관리	나트륨·당류 섭취 줄이기, 국물·가공식품·짠 반찬·단 음료 제한	상시
유산소 운동	빠르게 걷기, 자전거, 수영 등 숨이 약간 찰 정도의 중등도 운동. 당뇨병 병력이 있으면 저혈당 증상 주의	주 5회, 1회 30분
근력 운동	스쿼트, 런지, 로우, 푸시업 변형, 플랭크 등 전신 대근육 운동	주 2-3회
체지방 관리	단 음료·야식·정제 탄수화물 섭취를 줄이고 단백질·채소 중심 식사, 체중 5-10% 감량 목표	4주 후 재평가
자가 측정	혈압은 안정 후 2회 평균, 혈당은 공복/식후 여부를 구분해 기록	매일 또는 주 3회
추적 검사	공복혈당, HbA1c, 지질검사, 신장기능, 소변 알부민/크레아티닌비 등 확인	1-3개월

3. 복약 및 안전 안내

- 이 문서만 보고 혈압약, 당뇨약, 다이어트약, 이뇨제, 보충제를 임의로 시작하거나 중단하지 마십시오.
- 이미 복용 중인 약이 있다면 약 이름, 용량, 복용 시간을 정리하여 진료 시 제시하십시오.
- 운동 중 흉통, 호흡곤란, 어지러움, 실신감, 비정상적인 심계항진이 있으면 즉시 중단하고 진료를 받으십시오.
- 본 문서는 앱 데이터 흐름, 건강검진 PDF 생성, AI 소견 생성 기능을 시연하기 위한 샘플입니다.

가상 담당의: 홍길동 / 가정의학과 전문의(가상) 면허번호: SAMPLE-00000

처방전 발행기관: 헬스업 가상 건강관리센터 서명: 전자서명(샘플)